

Derivación urinaria — Comparación de sus opciones

Información para el paciente · Tres maneras de drenar la orina cuando se extirpa la vejiga o deja de funcionar

WARWIKI

Cuando se extirpa la vejiga o deja de funcionar, la orina necesita otra salida del cuerpo — esto se llama derivación urinaria. Hay tres tipos principales. Todos usan un trozo de su propio intestino y se diferencian sobre todo en **cómo vacía la orina a diario**: una bolsa en el abdomen, orinar por la uretra, o vaciar con una sonda. Esta hoja los compara; cada uno tiene además su propia hoja detallada.

Las tres opciones

LLEVA UNA BOLSA

Conducto ileal

Un trozo corto de intestino lleva la orina a una pequeña abertura (un **estoma**) en el abdomen, donde drena de forma constante a una **bolsa** ligera que usted vacía y cambia. Es el más sencillo y común; no hay nada que controlar ni cateterizar.

ORINA POR LA URETRA · SIN BOLSA

Neovejiga ortotópica

Una bolsa nueva hecha de intestino se conecta a su **uretra**, así orina de forma natural sin bolsa. Aprende a vaciar con un **horario** (día y noche), a veces necesita una sonda, y el escape es común al principio.

VACÍA CON UNA SONDA · SIN BOLSA

Continente cutánea (bolsa de Indiana)

Una bolsa interna de intestino almacena la orina, con una pequeña abertura que no gotea (a menudo en el **ombligo**). Sin bolsa — usted pasa una **sonda** por la abertura para vaciarla varias veces al día.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Derivación urinaria

Un nuevo camino para que la orina salga del cuerpo cuando la vejiga ya no está o no funciona.

Estoma

Una pequeña abertura en la piel, hecha de intestino, por la que pasa la orina.

Conducto

Un trozo corto de intestino que lleva la orina a un estoma (no la almacena).

Neovejiga

Una vejiga nueva hecha de intestino y unida a la uretra.

Continente

No gotea — usted controla cuándo se vacía.

Derivación incontinente

Drena todo el tiempo a una bolsa (el conducto ileal).

Cateterizar

Pasar un tubo delgado para drenar la orina.

Moco

Líquido resbaloso que produce el intestino; ver hebras en la orina es normal después de cualquier derivación.

¿CUÁL ES ADECUADA PARA MÍ? La mejor opción depende de su anatomía, función de los riñones, otras enfermedades, y la fuerza de sus manos y su vista (necesarias para cateterizar) — además de su estilo de vida y lo que más le importa. No todos pueden tener cada tipo. Su cirujano le dirá qué opciones son seguras para usted.

Cómo se comparan

	Conducto ileal	Neovejiga	Continente (Indiana)
Cómo vacía	Drena solo	Orina por la uretra	Sonda por el estoma
¿Lleva bolsa?	Sí	No	No
¿Necesita sonda?	No	A veces	Siempre, cada 4–6 h
Tamaño de cirugía	El menor	Mayor	Mayor
Esfuerzo diario	Vaciar y cambiar bolsa	Vaciado con horario, día y noche	Cateterizar y lavar

Preguntas para su cirujano

- ¿Para cuáles opciones soy **candidato**, y cuál me recomienda?
- ¿Cómo serán la **vida diaria** y el autocuidado con cada una?
- ¿Cómo afectará el **trabajo, ejercicio, sueño e intimidad**?
- ¿Cuáles son los principales **riesgos** y la posibilidad de necesitar otro procedimiento más adelante?

Igual en las tres

- Se usa un trozo de su **propio intestino**, así que el intestino tarda unos días en recuperarse tras la cirugía.
- El **moco** en la orina es normal — lo produce el intestino.
- Necesitará **seguimiento de por vida**, incluso controles de **vitamina B12** (el segmento de intestino puede bajar la B12 con los años).
- **Beba muchos líquidos** para mantener todo limpio.

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Hay tres maneras de derivar la orina — una **bolsa** (conducto ileal), orinar por la **uretra** (neovejiga), o vaciar con una **sonda** por una pequeña abertura (bolsa de Indiana).
2. Se diferencian sobre todo en el **cuidado diario**. La mejor opción depende de su salud y lo que le importa — y no todos pueden tener cada tipo.
3. Las tres usan intestino, así que comparten moco en la orina, unos días para que el intestino se recupere, y seguimiento de por vida. Lea la hoja detallada de la opción que elija.